讯飞晓医产品体验报告

从健康咨询到长期健康管理

测试版本：Android 2.11.0　测试时间：2026 年 7 月

目录

1 摘要 2

2 产品定位与目标用户 2

2.1 产品定位 2

2.2 目标用户与使用场景 3

3 用户痛点与价值主张 3

4 产品架构与健康管理闭环 4

5 四个核心体验场景 4

5.1 症状咨询与急症分流 4

5.2 检验报告解读 5

5.3 药品查询与用药安全 5

5.4 健康档案与持续管理 5

6 产品优势 6

7 核心问题分析 6

7.1 报告数据可信度 6

7.2 病史与用户信息忠实性 7

7.3 持续健康管理闭环 8

7.4 其他体验问题 8

7.4.1 普通咨询与 AI 诊室的切换 8

7.4.2 健康档案调用与长期用药记录 8

8 重点改进方案 8

8.1 可信基础层 9

8.2 体验优化层 9

8.3 长期价值层 10

9 总体评价 10

10 第四周学习反思 10

参考文献： 11

1 摘要

2026 年 7 月，我在 Android 2.11.0 版讯飞晓医上，用虚拟病例和模拟检验单体验了症状咨询、报告解读、药品查询和健康管理四个场景。测试重点是产品如何识别风险、使用档案数据，并把健康建议转化为后续行动。

AI 诊室在模拟急腹症场景中给出明确的就医分流；药品咨询提示了自行联用和停用抗凝药的风险；自测结果也能写入档案，供后续回答调用。测试同时发现，PDF 解读出现数值错读和遗漏，问诊摘要写入了用户未确认的病史，四周健康计划缺少按周执行和复盘安排。

从本次体验看，讯飞晓医已具备从健康咨询延伸到长期个人健康管理的基础。建议先让检验数据和问诊摘要可核对，再优化问诊切换与档案调用，最后把目标、提醒、记录和复盘接入同一套管理流程。

关键词：医疗人工智能；产品体验；健康档案；数据可信度；持续健康管理

表 1 实测发现与改进重点

已观察到的能力	优先修复的问题	长期管理的改进方向
结构化问诊、急症分流、用药劝阻、档案与自测联动。	核对报告提取值和病史来源，防止错误进入后续风险判断。	把建议转成目标、提醒、记录、复盘和调整。

2 产品定位与目标用户

2.1 产品定位

官网将讯飞晓医介绍为面向居民的 AI 健康助手，列出了症状自查、报告解读、用药指导、饮食运动建议和就医支持等功能〔1〕。

从本次体验看，讯飞晓医以 AI 健康咨询为入口，通过个人和家庭健康档案连接症状分流、报告和用药解读、健康自测及后续管理建议。

本轮测试聚焦咨询、分流和个人健康管理。在线问诊、家庭医生、付费及履约流程未完整体验。

2.2 目标用户与使用场景

表 2 目标用户与产品角色

用户层级	主要需求	产品承担的角色
核心用户	日常健康咨询、体检异常理解、代谢与慢病风险管理、健康数据沉淀。	复用档案数据，结合既往信息解释风险。
次级用户	轻中度症状下的初步风险判断、就医时机与科室选择。	识别危险信号，完成安全提示和就医分流。
家庭管理者	为父母、孩子或其他成员集中维护健康资料。	按家庭成员组织档案，本轮观察了切换后的信息隔离。

有急症信号或需要专业诊疗决策时，产品的主要作用是提示风险，帮助用户判断就医时机与去向。

3 用户痛点与价值主张

用户看到检验指标异常时，需要知道风险有多大、下一步该做什么。收到减重或控风险建议后，还需要明确的目标、记录方式和反馈。表 3 将这些任务与产品能力对应起来。

表 3 用户痛点与产品价值

用户痛点	对应产品能力	希望获得的价值
就医决策困难	风险识别、急症提示、科室与就医路径分流	知道是否需要尽快就医，以及下一步去哪里。
医学信息难懂	报告解读、药品查询、医学术语通俗化	把专业信息转换为可理解、可执行的说明。
健康数据分散	个人及家庭健康档案、数据写回和调用	减少反复描述，让建议建立在已有信息上。
风险难以长期管理	自测、健康计划、行为记录与反馈	从知道风险走向持续行动和动态调整。
家庭资料难管理	家庭成员档案和成员切换	在同一入口分别维护家庭成员的健康资料。

讯飞晓医的价值在于降低用户理解医学信息的门槛，并结合已有档案解释风险、给出下一步建议。这个价值取决于档案数据是否准确、完整、可追溯。

4 产品架构与健康管理闭环

图 1 展示健康问题如何进入咨询，档案如何参与风险解释，以及建议怎样指向日常管理或就医分流。图中的专业医疗服务分支表示建议的就医去向。

AI 咨询负责理解问题、补充信息、识别风险和引导用户进入合适的咨询模式。

健康档案保存个人和家庭成员的既往史、体征、自测与检查数据，供后续咨询调用。

健康管理承接目标、执行记录和复盘。测试中已观察到自测数据写回档案，后续咨询也调用了其中部分数据。

遇到急症信号或复杂问题时，AI 提供就医方向，由专业医疗服务承接后续诊疗。

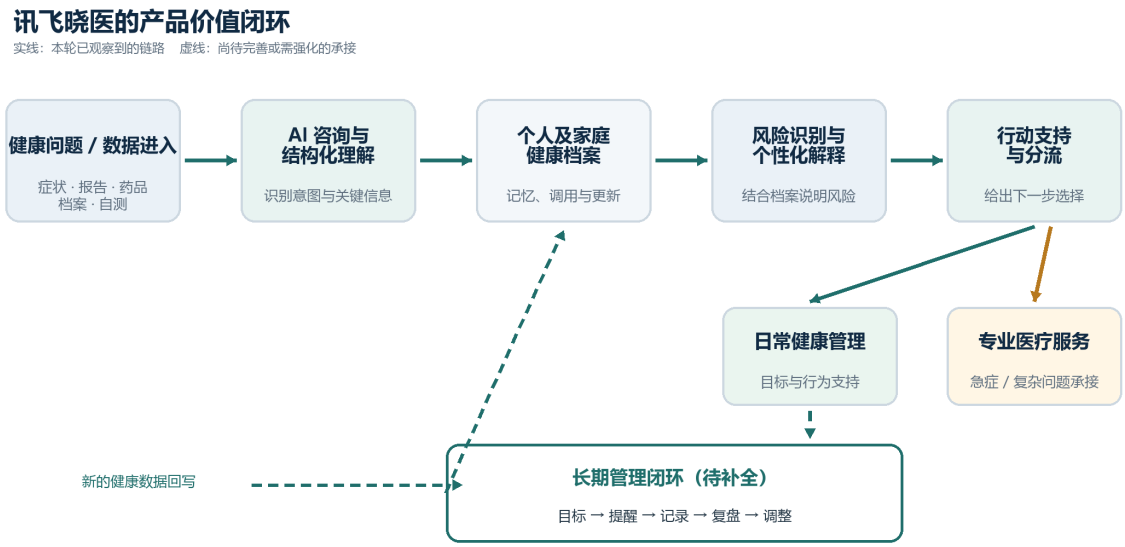


图 1　讯飞晓医产品架构与健康管理闭环

测试已经走通档案读取、自测写回和后续咨询调用。下一阶段要把建议进一步接到目标、提醒、记录、复盘和调整。

5 四个核心体验场景

5.1 症状咨询与急症分流

用户输入右下腹疼痛持续加重、伴有恶心和发热的模拟病例，希望判断就医的紧迫程度和科室。

普通咨询在病史尚不充分时先倾向胃肠炎或消化不良，随后给出热敷、按摩和散步等建议，急症提示夹在长篇回答中。AI 诊室逐项询问病史，最终提示疑似急性阑尾炎，并给出急诊科或普外科的就医方向。

结构化问诊给出了明确的就医方向。普通咨询应更早识别危险信号并引导切换；问诊摘要写入了未确认信息，具体例子见表 5。

5.2 检验报告解读

测试分别上传同一份模拟代谢检验单的图片版和 PDF 版，比较项目、结果、参考范围和异常标记。

图片版读对了多数主要结果。PDF 版出现数值错配、关键指标遗漏，还输出了原单没有的数值。移动端的宽表右侧不易查看。

数据读取正确时，系统能用较通俗的语言解释异常指标，并给出下一步建议。两种格式的识别差异见表 4。

5.3 药品查询与用药安全

测试先查询布洛芬的常规用药信息，再加入房颤和长期服用华法林的背景，观察回答如何处理联用与停药问题。

加入用药背景后，系统明确劝阻自行联用布洛芬与华法林，也提醒用户不要自行停用华法林。前一项提示与华法林和非甾体抗炎药（NSAIDs）联用的出血风险证据一致〔2〕；后一项涉及房颤抗凝决策，应引导用户咨询负责治疗的医生〔3〕。

基础查询未先确认品牌、规格和长期用药，部分关于替代药和停药的措辞也不够清楚。进入具体建议前，系统应主动核对这些信息。

5.4 健康档案与持续管理

测试先检查档案能否参与回答、健康自测结果能否写回档案，再请 AI 根据自测结果制定四周减重和缩腰计划。

自测读取了部分既有档案，并写回身高、体重、腰围、血压和风险结果，后续回答调用了其中部分数据。切换到另一测试档案后，回答中未出现原档案的房颤信息。

随后的建议遗漏了档案血压，体质指数（BMI）的计算值与档案显示也有差异。四周计划给出了饮食和运动建议，执行和复盘环节见第 7.3 节。

6 产品优势

用户可以直接描述症状，或询问报告、药品和健康管理问题。需要补充病史时，AI诊室会逐项询问；在模拟急腹症场景中，最终给出了明确的就医方向。

加入高风险用药背景后，系统劝阻危险联用和自行停药。读取数据准确时，系统能用通俗语言解释异常，并给出下一步建议。

个人档案会影响回答，自测结果能够写回档案供后续咨询使用。

7 核心问题分析

数据错读和病史补写会直接影响风险判断，应优先处理。持续健康管理的问题出现在建议给出之后：用户能否在同一流程里设定目标、记录进展并调整计划。

7.1 报告数据可信度

检验结果

序号	检验项目	英文缩写	结果	单位	参考范围	提示
1	空腹血糖	FPG	7.2	mmol/L	3.9 - 6.1	↑
2	糖化血红蛋白	HbA1c	6.3	%	4.0 - 6.0	↑
3	总胆固醇	TC	5.70	mmol/L	< 5.20	↑
4	低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	4.10	mmol/L	< 3.40	↑
5	高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	1.24	mmol/L	≥ 1.00	
6	甘油三酯	TG	1.48	mmol/L	< 1.70	
7	丙氨酸氨基转移酶	ALT	26	U/L	9 - 50	
8	天门冬氨酸氨基转移酶	AST	21	U/L	15 - 40	
9	血清肌酐	Cr	82	μ mol/L	57 - 97	
10	估算肾小球滤过率	eGFR	102	mL/min/1.73m2	≥ 90	

图 2 模拟代谢检验单关键区域

表 4 模拟检验单与 PDF 解读结果对照

项目	模拟单原值	PDF 解读结果	产品风险
FPG	7.2 mmol/L	5.70	异常被读成正常范围，可能改变风险判断。
HbA1c	6.3%	遗漏	缺少一项判断代谢风险的依据。
TC	5.70 mmol/L	6.21	结果无法在原单中核对。
ALT / AST	26 / 21 U/L	9 / 15	疑似把参考范围下限当成结果值。
肌酐	82 μmol/L	72	数值偏移，降低对整体解析结果的信任。

美国糖尿病协会将空腹血糖（FPG）≥7.0 mmol/L 列为糖尿病诊断标准之一；没有明确高血糖时，诊断需要确认性检测〔4〕。

模拟检验单的空腹血糖为 7.2 mmol/L，PDF 解读输出为 5.70，改变了该指标的异常判断。糖化血红蛋白（HbA1c）被遗漏，总胆固醇（TC）则被写成原单没有的 6.21。表 4 列出这些差异及其影响。

读取错误会传到异常识别、复查建议和就医提示。报告解读应先展示提取结果和原文位置，让用户核对后再生成解释。

7.2 病史与用户信息忠实性

AI 诊室给出了明确的分流方向，但摘要中有三项内容没有得到用户确认。问诊摘要可能供后续咨询或就医时使用，应区分用户确认的事实、模型推测和未询问的信息。

表 5 问诊摘要与用户输入对照

AI 最终摘要写入	本轮用户输入情况	问题性质
“无排尿异常”	用户未明确提供或确认	把未询问项目自动写成阴性事实
“既往体健”	用户未明确提供或确认	用概括性推断替代真实既往史
“疼痛位置和性质改变”	用户未明确描述这一变化	把模型推测写入症状演变

“无排尿异常”把未确认的症状写成阴性，“既往体健”替代了尚未完整采集的既往史，“疼痛位置和性质改变”则改写了症状演变。这三处改写都可能影响后续对病情的理解。

7.3 持续健康管理闭环

表 6 已观察到的数据流与待完善的管理流程

本轮已观察到	仍待形成的长期闭环
档案 → 自测 → 数据写回 → AI 调用 → 健康建议	目标 → 提醒 → 记录 → 复盘 → 调整
自测结果可以写回档案，后续回答会调用其中部分数据。	在测试路径中，建议还没有转成可跟踪的应用内任务。

系统生成的四周计划以通用饮食和运动建议为主，缺少逐周任务、检查点和调整规则。体重管理资料强调持续监测和合理设定目标〔5〕；对产品来说，这些要求需要落在可记录、可复盘的具体任务上。

持续管理需要把每次咨询后的目标、进度和反馈写入档案，供下一次咨询和计划调整使用。

界面可见健康管理计划入口。在本轮测试路径中，用户询问应用内记录和提醒时，AI 推荐了手机闹钟、手环或纸质记录，未把用户引导到应用内的提醒和复盘流程。

7.4 其他体验问题

7.4.1 普通咨询与 AI 诊室的切换

普通咨询在信息不足时就给出病因判断和生活建议。识别到症状或危险信号后，产品应先提示风险；需要进入 AI 诊室时，应带入用户已经提供的信息。

7.4.2 健康档案调用与长期用药记录

本轮未找到长期用药的结构化入口。档案中 145/92 mmHg 的血压在后续回答中连续遗漏，BMI 计算值与档案显示也不一致。建议同时检查关键字段的记录、更新时间和调用逻辑。

8 重点改进方案

优先让用户核对检验数据和病史。随后改进问诊切换、档案调用和移动端阅读，再用可信的数据支持持续记录和计划调整。表 7 列出了各层的重点动作和验证信号。

表 7 三层改进方案及验证信号

产品层级	核心目标	重点动作	有效信号
可信基础层	让输入、病史和结论可核对	结构化提取确认；低置信度提示；原文定位；事实/推测/未询问分层；摘要核对与修改。	抽查数据可对应原文，摘要事实可追溯到用户确认。
体验优化层	让用户在正确模式下完成任务	症状输入智能路由；危险信号优先；长期用药结构化；关键档案完整调用；移动端内容适配。	首屏可见急症提示；切换不丢信息；关键档案可完整调用。
长期价值层	把建议转成持续行动	设定阶段目标，按周安排任务、记录和提醒，复盘后调整计划。	用户能记录任务、查看复盘结果并调整下一周计划。

8.1 可信基础层

报告解读前展示项目、结果、单位、参考范围和异常标记。标明识别把握较低的字段，允许用户回看原文并修正。

在问诊摘要中标明用户已确认、模型推测和未询问的信息。提交前让用户核对事实，修正后同步更新分流建议。

高风险提示要说明判断依据和仍缺少的信息，明确下一步行动。

8.2 体验优化层

识别到危险信号或关键病史缺失时，优先追问或提示就医。切换到 AI 诊室时，说明切换原因并带入已填写的信息。

长期用药按药名、剂量、频次、起止时间和用药原因记录，同时保留来源和更新时间。房颤档案缺少抗凝信息时，主动询问。

移动端优先用纵向卡片展示长表，将异常项放在前面；需要横向滚动或展开时，明确提示还有未显示的内容。

8.3 长期价值层

解释影响风险的因素，让用户从可改变的因素中选定阶段目标。

按周安排任务和检查点，在计划页面提供记录和提醒入口，支持标记完成情况和遇到的困难。

提供周度或阶段复盘，根据体重、腰围、血压和任务完成情况调整下一周目标。

用户询问提醒或记录时，AI 应给出应用内可用入口；应用无法承接时，再推荐外部工具。

9 总体评价

讯飞晓医已经能把健康咨询与个人档案、自测和风险解释连起来。测试中，结构化问诊给出了明确的就医方向，档案也为后续回答提供了个性化信息。

影响信任的首要问题是报告数值错读和病史被补写。长期使用的主要障碍是健康建议与目标、记录、复盘之间缺少明确的承接。

下一阶段应先做报告原文核对和病史确认，再改进问诊切换与档案调用。这些信息稳定后，才能用后续记录可靠地调整健康计划。

10 第四周学习反思

体验前，我主要看 AI 能不能解释医学问题、给出下一步建议。对照检验单和问诊记录后，我更关注回答的依据：数值从哪里来，哪些病史由用户确认，发现风险后系统如何引导用户行动。

这次测试里，空腹血糖错读改变了异常判断，摘要补写改变了病例信息。后续设计应把原文核对、病史确认和急症分流写进流程，并为这些环节设置可检查的验收条件。

下一阶段写产品需求文档（PRD）时，我会把本次案例转成可复测的验收项：图片和 PDF 能否提取一致的结果，摘要能否回溯到用户原话，以及用户能否记录本周进展并在下周据此调整计划。

参考文献：

〔1〕讯飞晓医. 讯飞晓医官方网站〔EB/OL〕. https://chatdr.iflyhealth.com/，2026-11-10.

〔2〕VILLA ZAPATA L, HANSTEN P D, PANIC J, et al. Risk of bleeding with exposure to warfarin and nonsteroidal anti-inflammatory drugs: A systematic review and meta-analysis〔J〕. Thrombosis and Haemostasis, 2020, 120(7): 1066–1074. https://doi.org/10.1055/s-0040-1710592.

〔3〕JOGLAR J A, CHUNG M K, ARMBRUSTER A L, et al. 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS guideline for the diagnosis and management of atrial fibrillation〔J〕. Circulation, 2024, 149: e1–e156. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001193.

〔4〕AMERICAN DIABETES ASSOCIATION PROFESSIONAL PRACTICE COMMITTEE. 2. Diagnosis and classification of diabetes: Standards of Care in Diabetes—2026〔J〕. Diabetes Care, 2026, 49(Suppl 1): S27–S49. https://doi.org/10.2337/dc26-S002.

〔5〕国家卫生健康委员会. 居民体重管理核心知识（2024 年版）及其释义〔EB/OL〕. https://www.nhc.gov.cn/ylyjs/gzdt/202407/3673471d9f83465ea8c2a2ac30271250.shtml，2026-11-10.